

健康最適化の罫と検診・予防政策：医療倫理／公衆衛生倫理の観点から

緑秀会 田無病院 川瀬吉彦

February 21, 2026

Abstract

本稿は、検診・予防政策を「公衆衛生の実務」ではなく、医療倫理／公衆衛生倫理の観点から再定位する試みである。医療倫理の4原則（自律尊重・善行・無危害・正義）と、公衆衛生倫理における比例性・最小侵害の議論を踏まえつつ、近年の「健康の最適化（optimization）」というパラダイムが、医療の目的を生の支援（foundation）から延命・リスク最小化の達成それ自体（goal）へと転倒させうる点を論じる。

具体的には、健康を最適化すべき課題として捉えることで生じうる、(1)「今（而今）」の経験の希薄化、(2)意思決定の外在化に伴う自律性（agency）の毀損、(3)「良き生」からの乖離（死の不可視化と本来性の喪失）という三つの損失構造を整理し、検診・予防政策がこの転倒を増幅しうる条件（数値化、デフォルト設定、ナッジ、監視）を明示する。

なお本稿でいう「今（而今）」とは、単なる「現在時点」や刹那的快楽を指すのではなく、未来の最適化（延命やリスク最小化）に全面的に従属させられる以前の、当人がそのつどの生活世界の意味・価値を引き受けつつ経験する現在の厚み（生の手触り）を指す。したがって「今（而今）」の希薄化とは、健康管理が自己目的化し、評価指標や将来リスクの計算が日常の解釈枠組みを占有することで、現在の経験が常に「将来のための手段」として再記述されてしまう事態を意味する。

1 序論：公衆衛生倫理から医学哲学的考察へ

検診・予防政策は、個人診療と異なり、未受診者・無症状者をも対象化し、行動変容や受検を促す（時に事実上の圧力を伴う）点で、倫理的正当化のあり方が異なる。罹患率・死亡率・寿命短縮リスクなどの疫学指標は重要な根拠であるが、政策を正当化するためには、(i) 利益と害の比較衡量、(ii) 侵害の最小化、(iii) 公平性、(iv) 手続の透明性と説明責任が不可欠である [3, 4, 5, 6]。

現在の日本の検診制度は、自治体が実施する対策型検診と、企業・健保が実施する職域検診が併存し、対象年齢・頻度・精度管理・フォローアップ（精密検査への接続）・データ集計が分断されている。こうした分断は、(a) 過剰検査と見逃しが同時に生じうること（正義の観点での不均衡）、(b) 利害評価の一貫性が確保できないこと（無危害・比例性の弱体化）、(c) 説明責任の所在が不明確になること（透明性の低下）で、政策の正当化が困難になる。

また、公衆衛生の「高リスク・アプローチ」と「集団アプローチ」は、誰がどれだけ病気の負担を抱えているか、また介入によって誰がどれだけ利益・不利益を受けるかという構図そのものを

変えるため、何が正当で公正かという判断が不可避になる [2]。本稿は、医療 4 原則を起点に、検診・予防政策の評価・設計に必要な規範的論点を論文化する。

2 先行研究と理論枠組み

2.1 医療倫理 4 原則の公衆衛生への移植可能性

4 原則は臨床倫理で定式化されることが多いが、公衆衛生でも (1) 自律尊重＝強制・誘導の正当化条件、(2) 善行＝集団的健康利益、(3) 無危害＝介入が生む害の最小化、(4) 正義＝配分・格差・手続の公正として再解釈できる [6, 3]。

2.2 スクリーニング評価原理：Wilson–Jungner と「利益害のバランス」

スクリーニングの古典的基準として Wilson–Jungner の 10 原則がある [1]。ただし現代では、チェックリスト的適用よりも、健康アウトカムに関する系統的レビューに基づき、利益と害の大きさ (net benefit) を見比べて総合的に判断する考え方が重視される [7]。

2.3 公衆衛生倫理の正当化原理

Kass は、(1) 目的 (罹患・死亡の減少) (2) 有効性の根拠 (3) 負担の同定と最小化 (4) 公平な実施 (5) 負担の受容可能性を決める公正手続、という評価枠組みを提示した [3]。Upshur は害原則、最小制限手段、互惠、透明性を提示し、臨床倫理モデルの限界を指摘する [4]。Nuffield Council はスチュワードシップ・モデルと介入ラダーを示し、介入の侵襲性に比例して、より強い正当化を要求する [5]。

2.4 介入の梯子 (Intervention Ladder) の臨床的再構成

Nuffield Council が提示した「介入の梯子 (Intervention Ladder)」は、個人の自律・自由への制約が弱い介入から強い介入へと段階的に介入を並べることで、**侵襲性 (intrusiveness) に比例して、より強い正当化 (proportionality) が必要になる**という原理を見通しよく示す枠組みである [5]。

本稿では、この梯子を「公衆衛生 (制度)」における道具であると同時に、職域検診のように**個人が強い環境圧力にさらされる状況**を評価するための道具としても用いる。具体的には、下位段 (1–3) は「監視／情報提供／選択支援」として自律を中心に据え、中位段 (4–6) はデフォルトや誘導 (ナッジ) として実質的な選択環境を変える介入、上位段 (7–8) は選択を制限・排除する強制的介入として位置付けられる (既掲の 8 段階リスト参照)。

さらに、臨床現場へ再構成する際には、同じ「上位段の介入」であっても、(i) 急性期 (救命の時間制約)、(ii) 意思決定能力の低下、(iii) 介入による回復可能性、によって正当化条件が大きく変

わる点を明示しておく必要がある。すなわち、臨床的再構成とは、単に「介入を強くする／弱くする」のではなく、**疾患の緊急性と患者の自律性の状態に応じて、介入段階を可逆的に上下させる**という運用原理として理解されるべきである。

最後に、介入の梯子は「個人への介入」を中心に据えるため、構造要因（制度・職場文化・アクセス）を見えにくくし、責任を個人に帰属させやすいという批判もある [?]。したがって検診・予防政策を設計する際には、個人の受検行動に介入する以前に、説明責任、データの扱いの透明性、フォローアップ体制の整備等、**システム側の義務**を明確にする必要がある。

3 方法

本稿は、規範倫理学（概念分析・整合的反省）と、スクリーニング／公衆衛生倫理の主要文献の叙事的レビューに基づく理論的論考である。ここでの「平均余命の短縮」または「健康余命の短縮」は、政策評価上の死亡・罹患のリスク（絶対リスク、相対リスク、および健康余命に対する影響）として扱い、政策の意義を「集団利益」と「個人の権利・負担」の関係として分析する。

3.1 組織型検診（Organized Screening）への移行：制度統合と医療 DX の倫理

本稿の問題設定を日本のがん検診制度に即して具体化すると、最大の制度課題は、自治体の対策型検診と職域検診が並存し、受診履歴・精密検査の追跡・精度管理が分断されてきた点にある。分断は、(i) 受診率の「真の分母・分子」を確定できないこと、(ii) 要精検者のフォローアップが不完全になりうること、(iii) 検査プロトコルや精度管理の不統一を温存することを通じて、善行（集団利益）・無危害（害の最小化）・正義（格差と手続）のすべてを同時に劣化させる。

近年の政策議論は、対象者の特定（名簿管理）から受診勧奨（コール・リコール）、検査品質の担保、精密検査受診の追跡までを一つのプログラムとして統括する「組織型検診」へ移行することで、この分断を克服しようとしている（がん検診組織型への移行資料に基づく要約）。この移行は、単なる受診率向上策ではなく、データ連携と標準化を伴う医療 DX そのものであり、本人同意・透明性・目的外利用の抑制といった自律尊重の要件を満たす設計が不可欠である。

具体的には、職域等でのがん検診受診状況を市町村が把握する制度整備（指針改正）や、自治体検診 DX・PMH（Public Medical Hub）等の基盤を通じた一体的把握が議論されている（例：[2, 1]）。ただし、データの一元化は、(1) 本人の統制感（agency）を毀損しうる、(2) KPI 化・監査化によって検診が自己目的化しうる、という本稿の中心問題（健康最適化の罠）とも接続するため、比例性・最小侵害・説明責任の観点からの設計原理が必要となる（提案：同意手続の明確化、目的限定、オプトアウト容易性、精検フォローの実装責任の所在の明確化）。

3.2 数理統計学的補論：罹患率 α と寿命減少率 β に基づく介入ラダー（8 段階）への割当

疾患 X について、 α を「10 万人あたり罹患率」、 β を「罹患した場合の寿命減少率（期待される健康余命の比例的減少）」として、集団疾病負荷の粗い要約指標を

$$B_X := \alpha_X \beta_X \quad (1)$$

と定義する（ B_X は「10 万人あたりの期待寿命損失の相対指標」と解釈できる）。ただし α, β は推定量であり、観測誤差（診断基準・報告体制・コホート差）を伴うため、割当は点推定ではなく不確実性を含めて行うことが望ましい。

本補論の目的は、精緻な政策スコアを提示することではなく、**疾病負荷（ α, β ）と介入強度（ラダー段階）を接続するための概念モデル**を提示することである。したがって、年齢構造や競合リスク、介入の実装可能性等は明示的にモデル化しておらず、重み w_α, w_β やしきい値 τ_k の設定が価値判断（社会的合意）に依存する点は、本補論の限界として明記しておく。

介入ラダー（8 段階）への機械的な割当のために、候補疾患集合 $\mathcal{D}$ （政策として俎上に載る複数疾患）に対し、 $\log(\alpha + 1)$ および $\log(\beta + \epsilon)$ （ $\epsilon > 0$ は 0 回避の微小定数）を用いた標準化を行う：

$$z_{\alpha,X} := \frac{\log(\alpha_X + 1) - \mu_\alpha}{\sigma_\alpha}, \quad z_{\beta,X} := \frac{\log(\beta_X + \epsilon) - \mu_\beta}{\sigma_\beta}, \quad (2)$$

ここで $\mu_\alpha, \sigma_\alpha, \mu_\beta, \sigma_\beta$ は $\mathcal{D}$ 上での平均と標準偏差である。次に、重み $w_\alpha, w_\beta \geq 0$ （ $w_\alpha + w_\beta = 1$ ）を用いて重症度スコア

$$S_X := w_\alpha z_{\alpha,X} + w_\beta z_{\beta,X} \quad (3)$$

を定義する。直観的には、罹患率が高い（ α 大）か、罹患時の寿命影響が大きい（ β 大）ほど、 S_X は増加する。

介入ラダーの段階 $L_X \in \{1, \dots, 8\}$ は、しきい値列 $\tau_1 < \dots < \tau_7$ によって

$$L_X := 1 + \sum_{k=1}^7 \mathbf{1}\{S_X \geq \tau_k\} \quad (4)$$

と定める（例えば τ_k を S の分位点で設定すれば、候補疾患を 8 群に分割できる）。

最後に、ラダーの段階は「疾病負荷の大きさ」だけではなく「自律侵害の正当化可能性」（比例性・最小侵害）を反映させる必要があるため、実運用では、介入の実効性 E_X （アウトカム改善の大きさ）、害 H_X （偽陽性・過剰診断・合併症等）、および自律制限コスト C_X を併置して

$$\text{採否は } E_X - H_X - \lambda C_X \text{ が十分に正であるか} \quad (5)$$

を点検する（ $\lambda > 0$ は自律性コストの重み）。すなわち、 α, β はラダーを上げるための必要条件を与えるが、十分条件ではなく、同じ S_X でも、低侵襲で任意性の高い介入を優先し、強制性の高い介入は最後に位置付ける（介入ラダーの規範的含意）。

（参考：介入ラダーの 8 段階） (1) 何もしない／監視、(2) 情報提供、(3) 選択の支援、(4) デフォルト変更等による選択誘導、(5) インセンティブ、(6) ディスインセンティブ、(7) 選択制限、(8) 選択排除（義務化）。

3.2.1 補論：健康最適化パラダイムと「介入の梯子」の再解釈

介入の梯子は通常、自由制約の強弱に応じて「より強い正当化」を要求する枠組みとして読まれる。しかし現代の検診・予防政策では、自由制約が露骨な「強制」ではなく、**数値化（スコア化）・デフォルト化・ナッジ・監視**という形で生活世界に浸透しやすい。

健康が「最適化すべきタスク」とみなされると、政策の争点は「検査の是非」から、「何を健康と数えるか」「誰がその数え方を設計するか」「その設計が個人の時間と物語をどう組み替えるか」へと移行する。したがって本稿では、介入の梯子を、**自由の制約度**だけでなく、**生（時間・実存・物語）を手段化する度合い**を点検するための道具として再解釈する。

4 分析：4 原則に基づく検診・予防政策の正当化

本節では、4 原則（自律尊重・善行・無危害・正義）に沿って論点を整理し、各原則が職域検診を含む検診・予防政策に対して課す制度要件（情報提供、任意性、害の最小化、公正手続など）を、できるだけ明示的に示す。

4.1 自律尊重：同意なき対象化をどう正当化するか

個人診療ではインフォームド・コンセントが中心である一方、検診・予防政策は、(i) 参加が半ばデフォルト化しやすい、(ii) 行政・雇用・教育などの制度経路を通じた圧力が生じうる、という特徴を持つ。自律尊重は、単に「受ける／受けない自由」を形式的に残すだけでなく、選択が実質的に可能な情報環境（リスクの提示、利益・害の説明、オプトアウトの容易さ）を要請する [3, 5]。

ここで罹患率や寿命短縮リスクは、参加を促すメッセージの正当性に関わるが、相対リスクのみの提示や恐怖喚起は、判断を歪め、事実上の操作（manipulation）になりうる [8, 9]。したがって、自律尊重は、絶対リスクと不確実性、偽陽性・過剰診断を含む害を併記し、個人の価値（寿命延伸、生活の質、将来計画）に照らした選択を可能にするコミュニケーションを求める [8]。

4.2 善行：集団利益の最大化とその限界

公衆衛生における善行は、集団の罹患・死亡の低減である [3]。罹患率や寿命短縮リスクが大きい疾病ほど政策優先度が高い、という直観は一定の合理性を持つ。しかし善行は「利益の存在」を示すにとどまり、(1) 利益の確からしさ（エビデンスの質）、(2) 誰が利益を得るか、(3) どの程度の侵襲で得るか、を追加的に問う。

特に Rose が指摘したように、個人リスクが高い者に焦点化する高リスク戦略は効率的に見える一方、集団全体のリスク分布を小さく動かす戦略が、総疾病負荷をより下げることがある（予防パラドックス） [2]。しかし集団戦略は対象者が膨大で、個々人の利益が小さくなりがちであり、その場合、無危害や正義の観点（害の分布・負担の公正）がより強く問題化する。

4.3 無危害：過剰診断・偽陽性・医療化に伴う構造的な不利益

検診に伴う不利益は、侵襲検査や治療の合併症だけでなく、偽陽性に伴う不安、ラベリング（診断名付与）による心理社会的影響、保険・雇用上の不利益、過剰診断（臨床的には問題化しなかった病変の発見と治療）を含む [10, 12]。過剰診断は、介入が成功しているように見える（発見数が増える、5 年生存率が上がる）一方で、死亡率低下に結びつかない場合があり、評価指標の選択自体が倫理的論点となる [7, 11, 12]。

したがって無危害は、(i) 利益と害の比較（net benefit）、(ii) 害の最小化（最小侵害・最小制限手段）、(iii) 害の早期検出（監視と是正）、を制度要件として要請する [4, 5]。

4.4 正義：配分の正義と手続の正義

検診・予防政策は、公費・人的資源・検査枠といった希少資源を配分する。ここでは「効率」（最大の健康改善）と「公平」（格差縮小、アクセス保障）が緊張関係に立つ。Daniels は Rawls 的枠組みを背景に、健康の特別な道徳的重要性と、限られた資源の下での公正な優先順位付けを論じる [30]。この視点からは、罹患率・寿命短縮リスクが高い群（社会的弱者に偏在しやすい）への優先投資は、単なる効率ではなく、機会の公正（fair equality of opportunity）を回復する試みとしても正当化されうる。

一方で、リスク推定モデルが社会的偏りを内包する場合、政策が特定集団に不利益（監視・スティグマ・負担）を集中させうる。正義は、(1) アクセスの障壁（費用、地理、言語、時間）除去、(2) 利益と害の分布の点検、(3) 透明で参加可能な意思決定過程、を不可欠の条件として要求する [3, 4, 30]。

5 医療哲学的考察：健康最適化パラダイムの射程と限界

健康を単なる「最適化すべきタスク」と見なすと、医療は「生を支える基盤」ではなく、「未来のために現在を最小化管理する装置」へと変質しうる。本節では、**健康最適化の罠：失われる実存と自律性**で整理された損失構造を、検診・予防政策の倫理へ接続する。

5.1 「今（而今）」の喪失：未来最大化としての公衆衛生

最適化は本質的に未来の結果を最大化するために現在を配分する行為である。すると、受検・行動変容・生活管理は「将来のための準備」へと収斂し、生活世界の豊かさ（現在の充足）が、将来のリスク削減の名のもとに恒常的に先送りされる。

5.2 自律の毀損：数値化・ナッジ・監視による意思決定の外部化

健康がスコアや指標で語られるほど、身体は「私自身」ではなく「管理オブジェクト」へと変質する。さらに、デフォルトやナッジによって熟慮がバイパスされると、本人は行為の理由を自らの物語として引き受けにくくなる（作者性の喪失）。この点で、介入の梯子は「強制の有無」だけではなく、**意思決定が誰の側に残るのか**を点検する枠組みである [17]。

5.3 評価指標と監査：測定の目的化をめぐる

健康診断や行動変容施策が KPI（受診率、再検率、保健指導参加率、体重・HbA1c 改善率など）で運用されると、介入は「価値の実現」ではなく「指標の改善」へと傾きやすい。この転倒を説明する古典的知見として、**Goodhart の法則**（測定値が目標になると測定値としての機能を失う）[13] や、**Campbell の法則**（社会指標が意思決定に使われるほど、腐敗圧力を受け、監視対象の過程自体を歪める）[14] がある。

この点は、監査・評価が制度全体に波及する「監査社会」論とも整合する [15, 16]。すなわち、KPI が「説明責任」を担うはずが、現場では監視されるための成果が生産され（見かけの達成）、当事者の熟慮・納得・生活史（物語）といった質的次元が周縁化されうる。

したがって「KPI で運用される健康管理」が直ちに悪いのではなく、**指標が、目的（良き生）に従属しているのか／目的が指標に従属しているのか**を問い直すことが、医療哲学としての検診・予防政策の中心課題となる。

5.4 認知負荷と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げても、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負荷（cognitive load）と実務負担**を前提にして成立している。

認知負荷の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力（functional/interactive/critical health literacy）として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.5 言語多様性と出身国差：在日外国人の増加が提起する課題

近年、在日外国人の増加により、検診・予防政策は「平均的な日本語話者」を暗黙の標準として設計するだけでは不十分になっている [26]。日本語を第二言語として用いる人にとっては、通知・同意文書・説明資料が**外在的認知負荷**となり、理解不足がそのまま不利益（受診遅れ、フォローアップ逸脱、誤解に基づく拒否）に接続しうる。医療通訳等の言語的支援が安全性・理解・アクセスを改善しうることは、国際的にも繰り返し指摘されている [27, 28]。

さらに、公衆衛生の「公平」は、言語だけでなく**出身国による疾患頻度の差異**（例：結核、肝炎等）を含む疫学的異質性を前提に再設計される必要がある [29]。ここで求められるのは「特定集団の監視強化」ではなく、誤解やスティグマを最小化しつつ、**リスクと障壁に比例した支援**（情報の多言語化、ナビゲーション、アクセス保障）を整えることである。

5.6 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを損ない、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.7 支援介入の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、「すべての人に同じ支援を行う（普遍主義）」か「特定の人だけを支援する（ターゲティング）」か、という二分法だけでは捉えにくい。そこで、社会経済的状況の段階差（困難の程度）に応じて支援の強度を段階的に調整する**比例普遍主義（proportionate universalism）**が提案されている [23, 24]。+（比例普遍主義は、支援の対象を普遍的に確保しつつ、困難の程度に応じて支援の強度を段階的に調整するという考え方である。）

この枠組みのポイントは、「普遍（誰でも）」と「重点（必要な人に厚く）」を両立させ、結果として健康格差の社会的勾配（＝不利が大きいほど健康アウトカムが悪くなる傾向）を弱めることにあります。

また、「逆ケア法則（inverse care law）」とは、支援がより必要な集団ほど良質なケアを受けにくくなる、という経験則であり、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈でいう「適正な支援介入」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」という一点に収斂させるほど、受け手側の認知負荷と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのか**を、認知負荷・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。

5.8 認知負荷と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げて、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負荷（cognitive load）と実務負担**を前提にして成立している。

認知負荷の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力（functional/interactive/critical health literacy）として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.9 言語多様性と出身国差：在日外国人の増加が提起する課題

近年、在日外国人の増加により、検診・予防政策は「平均的な日本語話者」を暗黙の標準として設計するだけでは不十分になっている [26]。日本語を第二言語として用いる人にとっては、通知・同意文書・説明資料が**外在的認知負荷**となり、理解不足がそのまま不利益（受診遅れ、フォローアップ逸脱、誤解に基づく拒否）に接続しうる。医療通訳等の言語的支援が安全性・理解・アクセスを改善しうることは、国際的にも繰り返し指摘されている [27, 28]。

さらに、公衆衛生の「公平」は、言語だけでなく**出身国による疾患頻度の差異**（例：結核、肝炎、胃がん等）を含む疫学的異質性を前提に再設計される必要がある [29]。ここで求められるのは「特定集団の監視強化」ではなく、誤解やスティグマを最小化しつつ、**リスクと障壁に比例した支援**（情報の多言語化、ナビゲーション、アクセス保障）を整えることである。

5.10 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この観点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを損ない、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.11 支援介入の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、「すべての人に同じ支援を行う（普遍主義）」か「特定の人だけを支援する（ターゲティング）」か、という二分法だけでは捉えにくい。そこで、社会経済的状況の段階差（困難

の程度)に応じて支援の強度を段階的に調整する**比例普遍主義 (proportionate universalism)**が提案されている [23, 24]。

また、「逆ケア法則 (inverse care law)」とは、支援がより必要な集団ほど良質なケアを受けにくくなる、という経験則であり、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈でいう「適正な支援介入」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり (ナビゲーション、予約支援)、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」という一点に収斂させるほど、受け手側の認知負担と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのかを、認知負担・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。**

5.12 認知負担と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げて、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負担 (cognitive load) と実務負担**を前提にして成立している。

認知負担の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力 (functional/interactive/critical health literacy) として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件 (教育、言語、時間、生活の安定)**が問題化する。

5.13 言語多様性と出身国差：在日外国人の増加が提起する課題

近年、在日外国人の増加により、検診・予防政策は「平均的な日本語話者」を暗黙の標準として設計するだけでは不十分になっている [26]。日本語を第二言語として用いる人にとっては、通知・同意文書・説明資料が**外在的認知負荷**となり、理解不足がそのまま不利益（受診遅れ、フォローアップ逸脱、誤解に基づく拒否）に接続しうる。医療通訳等の言語的支援が安全性・理解・アクセスを改善しうることは、国際的にも繰り返し指摘されている [27, 28]。

さらに、公衆衛生の「公平」は、言語だけでなく**出身国による疾患頻度の差異**（例：結核、肝炎等）を含む疫学的異質性を前提に再設計される必要がある [29]。ここで求められるのは「特定集団の監視強化」ではなく、誤解やスティグマを最小化しつつ、**リスクと障壁に比例した支援**（情報の多言語化、ナビゲーション、アクセス保障）を整えることである。

5.14 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを侵食し、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.15 支援介入の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、普遍主義（universal）とターゲティング（targeted）の二分法では捉えにくく、社会的勾配に応じて支援強度を調整する**比例普遍主義（proportionate universalism）**が提案されている [23, 24]。

また、必要が大きい集団ほど良質なケアが届きにくいという「逆ケア法則（inverse care law）」は、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈でいう「適正な支援介入」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」に回収するほど、受け手側の認知負担と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのか**を、認知負担・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。

5.16 認知負担と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げても、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負担（cognitive load）と実務負担**を前提にして成立している。

認知負担の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負担（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力（functional/interactive/critical health literacy）として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.17 言語多様性と出身国差：在日外国人の増加が提起する課題

近年、在日外国人の増加により、検診・予防政策は「平均的な日本語話者」を暗黙の標準として設計するだけでは不十分になっている [26]。日本語を第二言語として用いる人にとっては、通知・同意文書・説明資料が**外在的認知負荷**となり、理解不足がそのまま不利益（受診遅れ、フォローアップ逸脱、誤解に基づく拒否）に接続しうる。医療通訳等の言語的支援が安全性・理解・アクセスを改善しうることは、国際的にも繰り返し指摘されている [27, 28]。

さらに、公衆衛生の「公平」は、言語だけでなく**出身国による疾患頻度の差異**（例：結核、肝炎等）を含む疫学的異質性を前提に再設計される必要がある [29]。ここで求められるのは「特定集団の監視強化」ではなく、誤解やスティグマを最小化しつつ、**リスクと障壁に比例した支援**（情報の多言語化、ナビゲーション、アクセス保障）を整えることである。

5.18 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを侵食し、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.19 支援介入の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、普遍主義（universal）とターゲティング（targeted）の二分法では捉えにくく、社会的勾配に応じて支援強度を調整する**比例普遍主義（proportionate universalism）**が提案されている [23, 24]。

また、必要が大きい集団ほど良質なケアが届きにくいという「逆ケア法則（inverse care law）」は、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈でいう「適正な支援介入」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」に回収するほど、受け手側の認知負荷と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのか**を、認知負荷・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。

5.20 認知負荷と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げても、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負荷（cognitive load）と実務負担**を前提にして成立している。

認知負荷の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力（functional/interactive/critical health literacy）として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.21 言語多様性と出身国差：在日外国人の増加が提起する課題

近年、在日外国人の増加により、検診・予防政策は「平均的な日本語話者」を暗黙の標準として設計するだけでは不十分になっている [26]。日本語を第二言語として用いる人にとっては、通知・同意文書・説明資料が**外在的認知負荷**となり、理解不足がそのまま不利益（受診遅れ、フォローアップ逸脱、誤解に基づく拒否）に接続しうる。医療通訳等の言語的支援が安全性・理解・アクセスを改善しうることは、国際的にも繰り返し指摘されている [27, 28]。

さらに、公衆衛生の「公平」は、言語だけでなく**出身国による疾患頻度の差異**（例：結核、肝炎、胃がん等）を含む疫学的異質性を前提に再設計される必要がある [29]。ここで求められるのは「特定集団の監視強化」ではなく、誤解やスティグマを最小化しつつ、**リスクと障壁に比例した支援**（情報の多言語化、ナビゲーション、アクセス保障）を整えることである。

5.22 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを侵食し、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.23 「差し伸べる手」の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、普遍主義（universal）とターゲティング（targeted）の二分法では捉えにくく、社会的勾配に応じて支援強度を調整する**比例普遍主義（proportionate universalism）**が提案されている [23, 24]。

また、必要が大きい集団ほど良質なケアが届きにくいという「逆ケア法則（inverse care law）」は、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈で「適正な差し伸べる手」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」に回収するほど、受け手側の認知負荷と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防

政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのか**を、認知負荷・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。

5.24 認知負荷と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げても、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負荷 (cognitive load) と実務負担**を前提にして成立している。

認知負荷の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力 (functional/interactive/critical health literacy) として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.25 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性 (financial strain や支払い遅延等) は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性 (housing/employment/debt)** が健康そのものを侵食し、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.26 「差し伸べる手」の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、普遍主義 (universal) とターゲティング (targeted) の二分法では捉えにくく、社会的勾配に応じて支援強度を調整する**比例普遍主義 (proportionate universalism)** が提案されている [23, 24]。

また、必要が大きい集団ほど良質なケアが届きにくいという「逆ケア法則 (inverse care law)」は、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈で「適正な差し伸べる手」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」に回収するほど、受け手側の認知負荷と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのか**を、認知負荷・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。

5.27 認知負荷と理解の社会的勾配：介入される側の負担

検診・予防政策は「情報提供」や「選択支援」を掲げて、受け手の側には、通知文書の理解、予約や受診の段取り、費用や休暇の調整、家族・職場との交渉、結果の解釈、再検査への移行など、多数のタスクが累積する。すなわち、政策はしばしば**受け手の認知負荷（cognitive load）と実務負担**を前提にして成立している。

認知負荷の観点では、作業記憶は有限であり、課題が複雑化し、外在的負荷（手続の煩雑さ、用語の難解さ、情報の分断）が増えるほど、学習・理解・判断に割ける余力が減ることが知られている [20]。したがって、同じ介入でも、「理解しやすい人」だけが利益を得る設計になれば、それ自体が正義（格差拡大）問題となる。

さらに、健康リテラシーは単なる読み書き能力ではなく、社会的・経済的条件と結びついた能力（functional/interactive/critical health literacy）として整理されており、理解度や活用能力が社会背景に強く依存することが指摘されている [21]。このため、説明責任やインフォームド・コンセントを強調するほど、**理解の前提条件（教育、言語、時間、生活の安定）**が問題化する。

5.28 経済的不安定性と健康格差：不安定は「健康」を侵食する

経済的不安定性（financial strain や支払い遅延等）は、健康アウトカムと関連するだけでなく、炎症・代謝などのバイオマーカーとも関連しうることが報告されている [22]。この視点からは、健康格差は「医療アクセス」の問題に還元されず、**不安定性（housing/employment/debt）**が健康そのものを侵食し、同時に受診・自己管理の余力（帯域/bandwidth）を奪う。

5.29 「差し伸べる手」の社会的要請：比例普遍主義と逆転した配分の是正

健康格差の縮小は、普遍主義（universal）とターゲティング（targeted）の二分法では捉えにくく、社会的勾配に応じて支援強度を調整する**比例普遍主義（proportionate universalism）**が提案されている [23, 24]。

また、必要が大きい集団ほど良質なケアが届きにくいという「逆ケア法則（inverse care law）」は、医療が市場的圧力にさらされるほど強まるとされる [25]。この文脈で「適正な差し伸べる手」とは、単なる情報の追加ではなく、**手続負担の肩代わり（ナビゲーション、予約支援）、経済的障壁の除去、信頼関係に根差すアウトリーチ**を含む。

結論として、政策が介入の正当化を「説明したから」「同意を得たから」に回収するほど、受け手側の認知負荷と社会背景の格差が見えにくくなる。したがって、医療哲学としての検診・予防政策は、**自律を尊重するとは何を誰に要求することなのかを、認知負荷・不安定性・差別/周縁化の条件とともに再記述する必要がある。**

5.30 付録（補足資料の取り込み方針）

本稿の補足資料として、NotebookLM で整理した政策資料・議事録の要約メモは別ファイル（notebooklm_notes.tex）に保持する。本文で参照した制度改正・医療 DX に関する論点は、一次ソース（notebooklm_sources.bib に登録）を引用し、NotebookLM 生成文は根拠としては用いない。

5.31 「良き生」からの乖離：死の隠蔽と手段の自己目的化

健康寿命の延伸やリスク最小化が至上命題になると、死は回避すべきエラーとして隠蔽され、有限性に基づく価値の問い（本来的な生き方）が後景化する。しかし「最適化された人生」と「良い人生」は同義ではない。検診・予防政策の倫理は、健康指標の改善だけでなく、**人が何を大切に生きて生きるか**という価値論と不可分である。

6 結論

検診・予防政策は、疫学的な疾病負荷（罹患率・寿命短縮リスク）を起点にしつつも、4 原則と公衆衛生倫理の枠組みを統合し、利益害のバランス、侵害の最小化、そして配分・手続の正義を満たすときにのみ正当化される。政策評価は、健康アウトカムのエビデンスだけでなく、誰がどの害を引き受け、誰がどの利益を得るかという分配問題を不可避に含む。今後は、過剰診断の推定とコミュニケーション、格差に配慮したアクセス設計、説明責任を担保する制度設計が、検診・予防政策の中核的倫理要件となる。

References

- [1] J. M. G. Wilson and G. Jungner. Principles and Practice of Screening for Disease. Public Health Papers No. 34. World Health Organization, Geneva, 1968.
- [2] G. Rose. Sick individuals and sick populations. International Journal of Epidemiology, 14(1):32–38, 1985.
- [3] N. E. Kass. An ethics framework for public health. American Journal of Public Health, 91(11):1776–1782, 2001.
- [4] R. E. G. Upshur. Principles for the justification of public health intervention. Canadian Journal of Public Health, 93(2):101–103, 2002.
- [5] Nuffield Council on Bioethics. Public health: ethical issues. Report, 2007.
- [6] J. F. Childress, R. R. Faden, R. D. Gaare, L. O. Gostin, J. Kahn, R. J. Bonnie, N. E. Kass, A. C. Mastroianni, J. D. Moreno, and P. Nieburg. Public health ethics: mapping the terrain. Journal of Law, Medicine & Ethics, 30(2):170–178, 2002.

- [7] R. Harris, G. F. Sawaya, V. A. Moyer, and N. Calonge. Reconsidering the criteria for evaluating proposed screening programs: reflections from 4 current and former members of the U.S. Preventive Services Task Force. *Epidemiologic Reviews*, 33(1):20–35, 2011.
- [8] G. Gigerenzer and A. Edwards. Simple tools for understanding risks: from innumeracy to insight. *BMJ*, 327(7417):741–744, 2003.
- [9] K. Witte and M. Allen. A meta-analysis of fear appeals: implications for effective public health campaigns. *Health Education & Behavior*, 27(5):591–615, 2000.
- [10] J. Brodersen and V. D. Siersma. Long-term psychosocial consequences of false-positive screening mammography. *Annals of Family Medicine*, 11(2):106–115, 2013.
- [11] R. Moynihan, J. Doust, and D. Henry. Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy. *BMJ*, 344:e3502, 2012.
- [12] H. G. Welch, L. Schwartz, and S. Woloshin. *Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health*. Beacon Press, 2011.
- [13] C. Goodhart. Problems of Monetary Management: The UK Experience. In *Papers in Monetary Economics*. Reserve Bank of Australia, 1975.
- [14] D. T. Campbell. Assessing the impact of planned social change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1):67–90, 1979.
- [15] M. Power. *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press, 1997.
- [16] M. Strathern. Improving ratings: audit in the British University system. *European Review*, 5(3):305–321, 1997.
- [17] T. Sharon. Self-tracking for health and the quantified self: re-articulating autonomy, solidarity, and authenticity in an age of personalized healthcare. *Philosophy & Technology*, 30:93–121, 2017.
- [18] D. Lupton. *The Quantified Self*. Polity Press, 2016.
- [19] S. Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs, 2019.
- [20] J. Sweller. Cognitive load during problem solving: effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2):257–285, 1988.
- [21] D. Nutbeam. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. *Health Promotion International*, 15(3):259–267, 2000.
- [22] C. L. Niedzwiedz, S. V. Katikireddi, A. Reeves, M. McKee, and D. Stuckler. Economic insecurity during the Great Recession and metabolic, inflammatory and liver function biomarkers: analysis of the UK Household Longitudinal Study. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 71(10):1005–1013, 2017.
- [23] M. Marmot. *Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review: Strategic Review of Health Inequalities in England post-2010*. 2010.

- [24] G. Carey, B. Crammond, and E. De Leeuw. Towards health equity: a framework for the application of proportionate universalism. *International Journal for Equity in Health*, 14:81, 2015.
- [25] J. Tudor Hart. The inverse care law. *The Lancet*, 297(7696):405–412, 1971.
- [26] 出入国在留管理庁. 在留外国人統計 (Statistics on Foreign Residents) . (最新年版) .
- [27] G. Flores. The impact of medical interpreter services on the quality of health care: a systematic review. *Medical Care Research and Review*, 62(3):255–299, 2005.
- [28] World Health Organization. Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region. 2018.
- [29] World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023. 2023.
- [30] N. Daniels. Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press, 2008.

References

- [1] デジタル庁. 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム (public medical hub : pmh) . Web サイト, 2026. URL <https://www.digital.go.jp/policies/posts/public-medical-hub>. 最終更新日: 2026 年 2 月 6 日.
- [2] 厚生労働省健康・生活衛生局長. がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について. 健生発 0701 第 9 号, 厚生労働省, 7 2025.